

Pełny protokół — *alternatywa CBT-E dla dorosłych*

MANTRA — zintegrowany model: styl poznawczy + relacje + emocje + tożsamość. Druga obok CBT-E rekomendowana terapia AN dla dorosłych (NICE NG69).

CZAS: 20–30 sesji, 12 miesięcy

REALIZACJA: dorośli (od 17–18 lat), ambulatoryjnie lub w programie dziennym

ŹRÓDŁO: Schmidt & Treasure (2013, *MANTRA Workbook*); Schmidt i in. (2015, RCT MOSAIC); NICE NG69 (2017, rekomendacja)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **cztery moduły MANTRA** (styl poznawczy, relacje społeczne, emocje, tożsamość) + porównanie z CBT-E. Sekcja 02 — **siedem etapów protokołu**: zaangażowanie → zmiana → utrwalenie. Sekcja 03 — **karta zaangażowania**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

MANTRA (Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment for Adults; Schmidt & Treasure, 2013) — zintegrowany model terapii AN oparty na *czterech głównych obszarach* uznawanych za podtrzymujące w AN: (1) *nieelastyczny styl poznawczy* (uwaga na szczegóły, sztywność, perfekcjonizm), (2) *trudności w relacjach społecznych*, (3) *unikanie emocji*, (4) *tożsamość zbudowana wokół AN*. **Status:** druga obok CBT-E rekomendowana terapia AN dla dorosłych w wytycznych NICE NG69 (2017). RCT MOSAIC (Schmidt i in., 2015): MANTRA i SSCM (Specialist Supportive Clinical Management) o porównywalnej skuteczności u dorosłych. **Charakter:** bardziej elastyczna niż CBT-E, więcej eksternalizacji AN, więcej pracy z tożsamością i relacjami. Dobre wybory: pacjenci z dłuższą historią AN, z silną komponentą tożsamościową, lub którzy „*nie pasują*” do CBT-E.

01 Cztery moduły MANTRA — co terapia obejmuje

MODUŁ	PRACA KONKRETNA
1 · Styl poznawczy	Praca z nieelastycznością myślenia, perfekcjonizmem, uwagą na szczegóły kosztem całości. Ćwiczenia: „ <i>big picture</i> ” myślenie, elastyczność, tolerancja niejednoznaczności. Eksperymenty z mniej-niż-idealnymi rozwiązaniami.
2 · Relacje społeczne	Identyfikacja izolacji, lęku społecznego, perfekcjonizmu w relacjach. Zarysowanie więzi, eksperymenty z asertywnością, wyrażaniem potrzeb. Praca z systemem rodzinnym jeśli aktywne czynniki.
3 · Emocje	Praca z unikaniem emocji, niską tolerancją afektu, użyciem AN jako regulatora. Identyfikacja emocji, tolerancja, ekspresja. Czasem integracja z DBT skills.
4 · Tożsamość	Eksternalizacja AN (zob. karta externalizacja), „ <i>list do AN</i> ”, „ <i>list pożegnalny</i> ”, „ <i>kim jestem bez AN</i> ”. Praca nad wartościami, rolami, sieciami społecznymi. Najsilniejsza komponenta tożsamościowa wśród terapii AN.

MANTRA vs CBT-E: CBT-E ma jeden centralny mechanizm (*nadwartościowanie*) i bardziej protokołową strukturę. MANTRA ma cztery równorzędne i większą elastyczność. Wybór: kompetencje terapeuty, preferencje pacjenta, profil kliniczny. Skuteczność porównywalna w RCT.

02 ☉ Siedem etapów protokołu MANTRA

1. **Zaangażowanie i budowanie przymierza (sesje 1-4)** — MI, eksternalizacja AN od pierwszej sesji. Praca z ambiwalencją: „co AN Ci daje, co Ci zabiera”. Bilans decyzyjny. Wprowadzenie zeszytu pracy (*MANTRA workbook*).
2. **Diagnoza czterech obszarów (sesje 3-6)** — zarysowanie: który z czterech modułów jest dla pacjenta najbardziej aktywny. Dla każdego — konkretne przykłady z życia. Wybór 1-2 priorytetowych do pracy.
3. **Praca nad jedzeniem (równoległe od sesji 4)** — choć tożsamość i emocje są centralne, MANTRA *nie pomija* jedzenia. Regularne jedzenie, rehabilitacja żywieniowa, koordynacja z dietetykiem. Mniej protokołowo niż CBT-E.
4. **Praca z priorytetowym modułem (sesje 6-15)** — koncentracja na 1-2 modułach najsilniej aktywnych. Konkretnie techniki dla każdego: ćwiczenia poznawcze (moduł 1), eksperymenty społeczne (2), praca z emocjami (3), tożsamość (4).
5. **List do AN i list pożegnalny (sesje 12-20)** — narzędzia charakterystyczne dla MANTRA. „List do AN jako przyjaciela” → „list do AN jako wroga” → „list pożegnalny” (zob. osobne karty). Sygnalizują kolejne etapy zmiany.
6. **Konsolidacja i tożsamość (sesje 18-25)** — „kim jestem bez AN” — najtrudniejsza faza. Pustka po AN, budowanie nowej tożsamości, wartości, ról. Rozszerzanie sieci wsparcia.
7. **Profilaktyka nawrotu i zakończenie (sesje 25-30)** — plan utrzymania zmiany, identyfikacja sygnałów wczesnych nawrotu, sieć wsparcia. Stopniowe odstępy między sesjami (co 2 tyg., co miesiąc).

03 Karta zaangażowania w MANTRA — pierwsze sesje

CZEGO OCZEKUJĘ OD MANTRA

— co chciałbym/-łabym, żeby się zmieniło w moim życiu

KTÓRY Z CZTERECH MODUŁÓW WYDAJE MI SIĘ NAJBARDZIEJ AKTYWNY

— styl poznawczy, relacje, emocje, tożsamość; często więcej niż jeden

CO AN MI OBECNIE DAJE (JAKIE KORZYŚCI)

— kontrola, bezpieczeństwo, tożsamość, regulacja emocji, „specjalność”

CO AN MI ZABIERA (KOSZTY)

— zdrowie, relacje, marzenia, wolność

Klucz: MANTRA i CBT-E mają porównywalną skuteczność u dorosłych z AN (RCT MOSAIC 2015) — wybór zależy od kompetencji terapeuty, preferencji pacjenta i profilu klinicznego. **MANTRA pasuje szczególnie:** pacjenci z dłuższą historią AN, silną komponentą tożsamościową, izolacją społeczną, trudnościami w przymierzu terapeutycznym (eksternalizacja pomaga), niechętni do struktury CBT-E. **Komunikat dla pacjenta:** „MANTRA to pełna terapia AN — będziemy pracować nad jedzeniem, ale też nad emocjami, relacjami, tym kim jesteś poza AN. To długa praca — rok pracy. Każdy etap ma swój sens”.

⚠ **MANTRA nie jest „łagodniejszą” wersją CBT-E** — to inny model z innym akcentem. Wymaga osobnego szkolenia. Stosowanie MANTRA „na oko” (bez znajomości protokołu, bez workbooka Schmidt & Treasure 2013) ryzykuje rozmycie struktury i obniżenie skuteczności. Terapeuta powinien mieć formalne szkolenie MANTRA lub równoważne kompetencje w pracy z AN.